瑞慈体检
RICI HEALTH CHECKUP

好体检 中国有瑞慈

个人健康体检报告

HEALTH CHECKUP REPORT

莫增涛　　男　　38岁

0491212607313023

单位名称：星级客户

部门名称：QD

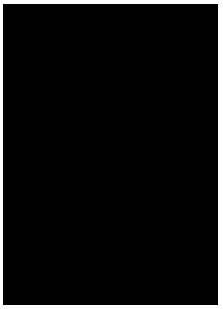
体检机构：青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查日期：2026-07-31

目录
CONTENTS

01 体检报告首页 Cover Page Of Medical Examination Report 1
02 异常结果与健康建议 Abnormal Findings and Health Recommendations 2
03 体格检查报告 Healthcare Checkup Report 4
04 检验综合报告 Laboratory Test Repor 6
05 超声检查报告单 Ultrasound Examination Report 11
06 影像诊断报告单 Diagnostic Imaging Report 14
07 心电图检查报告单 ECG Report 16
08 专家健康宣教 Expert Health Education 17

体检报告首页 Cover Page Of Medical Examination Report



体检机构：青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部 **体检日期：**2026-07-31

姓名：莫增涛 **性别：**☑ 男 ☐ 女 **婚姻状况：**☑ 已婚 ☐ 未婚

出生日期：1987-10-25 **身份证号：**411224198710250713

本人联系电话：15964994526 **邮箱 (选填)：**

住址：山东省青岛市市南区田家村457号

紧急联络人： **联络人电话：** **与您的关系：**☐ 父母 ☐ 配偶 ☐ 子女 ☐ 其他

体检类型： ☐ 个人健康体检 ☑ 单位健康体检 ☐ 入职体检 ☐ 其他 (请描述)

温馨提示 Warm Reminder

您好！衷心感谢您选择瑞慈，给予瑞慈医疗信任和配合，顺利完成本次健康体检。

本报告为您本次健康体检的客观记录，仅作健康筛查参考，不可替代临床诊断。 受目前医学技术客观局限、个体生理差异、以及您所提供的健康信息完整度的影响，本报告内所有数据与结论仅针对本次选定的检查项目，无法覆盖未选择项目所能筛查的人体组织、器官与全身系统的数据与结论。

当您获取到体检报告后，请一定完整仔细阅读您的体检报告。

本次体检检出的异常指标，建议您按照体检报告建议及时前往正规医院进一步完善专科检查及诊疗、定期随访复查，便于临床医生有更详实的医学证据去建立医学判断，避免延误诊治。

即便本次体检项目结果未见异常，也不代表机体绝对无疾患。建议坚持每年健康体检，践行健康生活方式。一旦身体出现不适症状，请您及时前往正规医院就诊。

数据说明：本报告归集您在瑞慈医疗历年存档体检数据。当历史检测项目参考区间与本次参考区间存在差异时，将在对应历史记录项下备注说明；参考区间一致则不予重复展示，便于受检人比对历年健康趋势。

如有报告解读疑问，可联系机构客服或致电瑞慈全国服务热线4001688188申请报告解读，我们将为您提供免费专业的报告解读。

祝您身体健康、万事顺遂！

异常结果与健康建议 Abnormal Findings and Health Recommendations

一、本次体检的主要异常结果及建议

此处所列为本报告中最具临床意义的问题。我们综合评估了各项异常的潜在风险及现行诊疗指南，对健康危害明确、需及时干预或专科就诊的项目予以重点标注。其分类核心是干预的紧迫性与必要性，旨在提示您优先处理这些问题，防止疾病进展或延误治疗。

1.左肺下叶磨玻璃小结节

本次胸部CT新发现左肺下叶磨玻璃小结节，直径约5mm，边界清晰。磨玻璃结节是需要重视的肺部影像表现，建议半年后呼吸内科就诊复查，由专科医生综合评估。期间如出现咳嗽、胸痛、咯血等不适，请及时就医。

二、本次体检的其他异常结果汇总及建议

此处汇总了本次体检中风险等级相对较低的其他异常。这些问题多处于早期或尚不需临床干预，但仍需持续跟踪观察。其目的是在疾病形成或加重前进行早期预警。请您根据附注的随访建议择期复查，做好日常健康管理。

超声成像检查

1.甲状腺左叶结节（C-TIRADS3类）

本次超声提示左叶甲状腺多发结节，较大者约7.3×4.2mm，分类为C-TIRADS3类。与一年前（C-TIRADS4A类）相比，本次分类有所降级，但此类结节仍有约2%的微小恶变风险，需动态观察。建议您保持规律作息，心情舒畅，定期复查甲状腺超声，如出现颈部肿胀或声音嘶哑等不适，及时到内分泌科或甲状腺外科就诊。

2.胆囊息肉

本次超声提示胆囊附壁见稍高回声区，大小约8.1×4.3mm，考虑为胆囊息肉。与既往（一年前约9.0×6.2mm）相比，大小无明显增大。建议您日常保持低脂饮食、规律进餐，定期复查腹部超声，动态观察息肉大小及形态变化。如息肉持续增大或出现右上腹不适，请及时到肝胆外科就诊。

3.前列腺囊肿

本次超声提示前列腺内见无回声区，大小约11.8×8.4mm，呈泪滴状，考虑为前列腺囊肿。此为良性改变，通常无明确临床意义。建议您日常避免久坐，适当运动，多饮水，勿憋尿，定期随诊复查即可。如出现排尿不畅或下腹不适，可到泌尿外科咨询。

4.前列腺钙化

本次超声提示前列腺内见钙化斑，结合您一年前及更早期超声，钙化斑持续存在，为前列腺慢性炎症或既往炎症愈合后留下的稳定痕迹，无临床风险。无需特殊处理，建议您保持健康生活方式，定期随诊观察。如出现排尿异常等症状，可至泌尿外科就诊。

X线计算机体层成像（CT）检查

5.两肺多发微小结节

本次胸部CT新发现两肺多发微小结节，最大者位于右肺下叶，直径约2mm。此类微小结节通常以定期复查为主，但因多发且为首次发现，建议您到呼吸内科随诊，由专科医生评估并制定后续随访方案。日常注意避免吸烟及粉尘接触，如出现呼吸道症状，及时就医。

6.右肺上叶陈旧性病灶可能

本次胸部CT提示右肺上叶见斑点、斑片及条索状高密度影伴钙化，考虑为陈旧性病灶可能（既往炎症或感染后愈合遗留）。此非活动性病变，但建议您到呼吸内科就诊，由医生结合临床判断是否需要进一步检查。

7.气管憩室

本次CT提示气管旁见含气囊腔影，考虑为气管憩室。此为气管壁的良性膨出，多为先天性或长期慢性压力所致，与一年前CT发现一致，通常无明显症状。建议您定期随诊复查，如出现反复咳嗽、咳痰或异物感，可到呼吸内科就诊。

8.右侧胸膜增厚伴钙化

本次CT提示右侧胸膜增厚伴钙化，此为胸膜既往炎症或感染后修复形成的慢性、稳定性改变，本身通常无临床症状且不危及健康。建议您定期随诊复查胸部CT，观察有无变化。如出现胸痛、呼吸困难等不适，及时到呼吸内科就诊。

9.肝内低密度影

本次CT检查附见肝内类圆形低密度影，而本次超声检查对应部位未见明显占位。CT与超声表现不一致，需进一步明确其性质。建议肝胆外科就诊，由专科医生结合这两种检查结果综合评估。

主检医师：

青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部 体检专用章

青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司
市南门诊部

终检时间：2026-08-02 10:16

健康建议常用术语注解　Annotation of Common Terminology

随诊	如有不适或不适加重，应及时去医院就诊。
诊治	需要到医院专科明确诊断和(或)治疗。
复查	需短期内复诊，对结果确认和动态观察。
定期复查	在一定时间内对体检结果进行动态观察。
进一步检查	需扩大检查范围或采用其他检查方法明确诊断。
就诊	需到医院接受治疗。

若需查询《健康自测问卷》
（客户填写部分）的全部内容，请扫码获取

预约/报告

若需查询历史报告，请扫码获取

体格检查报告 Healthcare Checkup Report

【一般检查】

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	2024-09-28
身高	171.0 cm		170.5 cm	171.5 cm
体重	60.4 kg		62.0 kg	61.6 kg
体重指数BMI	20.7	18.5~23.9	21.3	20.9
收缩压	112 mmHg	90~139 mmHg	107 mmHg	108 mmHg
舒张压	64 mmHg	60~89 mmHg	69 mmHg	68 mmHg
腰围	77.0 cm			
臀围	91.0 cm			
腰臀比	0.85	0.85~0.9		

检查者：宋安平

【内科】

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	2024-09-28
既往史(内)	无特殊			
主诉	无特殊			
个人史	无特殊			
家族疾病	无特殊			
营养	营养良好		营养良好	营养良好
面容	正常		正常	正常
心率	72 次/分	60~100 次/分	68 次/分	64 次/分
心律	齐		齐	齐
心音	正常		正常	正常
心脏杂音	无		无	无
肺部	两肺呼吸音正常		两肺呼吸音正常	两肺呼吸音正常
腹部	未见异常		未见异常	未见异常
肝脏	肋下未及		肋下未及	肋下未及
脾脏	肋下未及		肋下未及	肋下未及

检查医师：

【眼科】

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	2022-10-08
裸眼视力右		1~2		
裸眼视力左		1~2		
戴镜视力右	1.5	1~2	1.0	1.5
戴镜视力左	1.5	1~2	1.0	1.5
外眼检查	未见异常		未见异常	未见异常

检查医师：

【耳鼻喉】

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	2022-10-08
耳	未见异常		未见异常	未见异常
鼻	未见异常		未见异常	鼻中隔右偏曲
口咽	未见异常		未见异常	未见异常

检查医师：

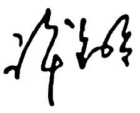
检验综合报告 Laboratory Test Report

【血液常规(五分类)】

检验中心： 青岛机构检验科

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	历史结果 2024-09-28
白细胞	4.18 *10^9/L	3.5~9.5 *10^9/L	3.92 *10^9/L	4.19 *10^9/L
中性粒细胞百分比	54.30 %	40~75 %	48.90 % ↓ 参考值：50~70 %	43.80 % ↓ 参考值：50~70 %
淋巴细胞百分比	36.50 %	20~50 %	41.30 % ↑ 参考值：20~40 %	47.40 % ↑ 参考值：20~40 %
单核细胞百分比	7.70 %	3.0~10.0 %	8.00 % 参考值：3.0~8.0 %	7.30 % 参考值：3.0~8.0 %
嗜酸性粒细胞百分比	0.90 %	0.4~8 %	1.10 % 参考值：0.5~5 %	0.90 % 参考值：0.5~5 %
嗜碱性粒细胞百分比	0.60 %	0~1 %	0.70 %	0.60 %
中性粒细胞数	2.26 *10^9/L	1.8~6.3 *10^9/L	1.92 *10^9/L ↓ 参考值：2~7 *10^9/L	1.82 *10^9/L ↓ 参考值：2~7 *10^9/L
淋巴细胞数	1.53 *10^9/L	1.1~3.2 *10^9/L	1.62 *10^9/L 参考值：0.8~4 *10^9/L	1.99 *10^9/L 参考值：0.8~4 *10^9/L
单核细胞数	0.32 *10^9/L	0.1~0.6 *10^9/L	0.31 *10^9/L 参考值：0.12~0.8 *10^9/L	0.31 *10^9/L 参考值：0.12~0.8 *10^9/L
嗜酸性粒细胞数	0.040 *10^9/L	0.02~0.52 *10^9/L	0.040 *10^9/L ↓ 参考值：0.0500~0.500 *10^9/L	0.040 *10^9/L ↓ 参考值：0.0500~0.500 *10^9/L
嗜碱性粒细胞数	0.030 *10^9/L	0~0.06 *10^9/L	0.030 *10^9/L 参考值：0~0.1 *10^9/L	0.030 *10^9/L 参考值：0~0.1 *10^9/L
红细胞	4.79 *10^12/L	4.3~5.8 *10^12/L	5.04 *10^12/L	5.01 *10^12/L
血红蛋白	146 g/L	130~175 g/L	153 g/L	149 g/L
红细胞压积	0.46 L/L	0.40~0.50 L/L	48.10 % 参考值：40~50 %	43.80 % 参考值：40~50 %
平均红细胞体积	96.8 fL	82~100 fL	95.4 fL	87.5 fL
平均血红蛋白量	30.48 pg	27~34 pg	30.36	29.74
平均血红蛋白浓度	314.00 g/L ↓	316~354 g/L	318.00 g/L	341.00 g/L
红细胞分布宽度-SD	41.8 fL	21~52 fL	40.7 fL	38.2 fL
血小板	183.00 *10^9/L	125~350 *10^9/L	181.00 *10^9/L 参考值：100~300 *10^9/L	192.00 *10^9/L 参考值：100~300 *10^9/L
血小板平均体积	8.0 fL ↓	9.0~13.00 fL	8.1 fL 参考值：6.5~12.00 fL	8.3 fL 参考值：6.5~12.00 fL
血小板分布宽度	15.8 fL	9~17 fL	15.6 %	15.6 %
血小板压积	0.15 %	0.108~0.374 %	0.15 % 参考值：0~2.9 %	0.16 % 参考值：0~2.9 %

检查者： 

审核者： 

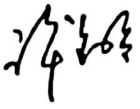
采样时间： 2026-07-31 07:35

报告时间： 2026-07-31 09:54

【尿常规15项】

检验中心： 青岛机构检验科

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	2024-09-28
尿胆原	阴性	阴性～弱阳性	阴性	阴性
胆红素	阴性	阴性	阴性	阴性
尿酮体	阴性	阴性	阴性	阴性
隐血	阴性	阴性	阴性	阴性
尿蛋白	阴性	阴性	阴性	阴性
亚硝酸盐	阴性	阴性	阴性	阴性
尿白细胞	阴性	阴性	阴性	阴性
尿糖	阴性	阴性	阴性	阴性
尿比重	1.025	1.005~1.030	1.015 参考值：1.003~1.030	1.015 参考值：1.003~1.030
酸碱度	5.50	5.4~8.4	7.50	6.00
维生素C	阴性	阴性	阴性	阴性
镜检白细胞	0 Cell/HP	0~5 Cell/HP	0 Cell/HP	0 Cell/HP
镜检红细胞	0 Cell/HP	0~3 Cell/HP	0 Cell/HP	0 Cell/HP
镜检管型	0 Cast/LP	阴性 Cast/LP	0 Cast/LP	0 Cast/LP
镜检结晶	未见 -	未见 -	未见 -	未见 -

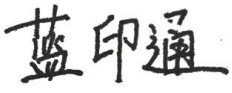
检查者：  　　**审核者：** 

采样时间： 2026-07-31 08:17　　**报告时间：** 2026-07-31 11:10

【肝功能四项】

检验中心： 艾迪康

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	2024-09-28
血清丙氨酸氨基转移酶	11 U/L	9~50 U/L	19.50 U/L 参考值：0~40 U/L	17.41 U/L 参考值：0~40 U/L
血清天冬氨酸氨基转移酶	20 U/L	15~40 U/L	21.72 U/L 参考值：0~40 U/L	18.64 U/L 参考值：0~40 U/L
谷草/谷丙	1.82 /	/ /	1.11 参考值：1.00~3.00	1.07 参考值：1~3
血清γ-谷氨酰基转移酶	19 U/L	10~60 U/L	15.00 U/L	17.00 U/L

检查者：  　　**审核者：** 

采样时间： 2026-07-31 07:35　　**报告时间：** 2026-08-01 00:34

【肾功三项】

检验中心： 艾迪康

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	历史结果 2024-09-28
血清尿素	4.13 mmol/L	3.10~8.00 mmol/L	3.92 mmol/L 参考值：1.7~8.3 mmol/L	4.48 mmol/L 参考值：1.7~8.3 mmol/L
血清肌酐	76 μmol/L	57~97 μmol/L	84.77 umol/L 参考值：44.2~106.1 umol/L	79.43 umol/L 参考值：44.2~106.1 umol/L
血清尿酸	249 μmol/L	208~428 μmol/L	264.98 umol/L 参考值：208~428 umol/L	227.09 umol/L 参考值：202~416 umol/L

检查者： 蓝印通 **审核者：** 李媛

采样时间： 2026-07-31 07:35 **报告时间：** 2026-08-01 00:34

【空腹血糖（GLU）】

检验中心： 艾迪康

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	历史结果 2024-09-28
空腹血糖	4.32 mmol/L	3.90~6.10 mmol/L	5.10 mmol/L	5.18 mmol/L

检查者： 蓝印通 **审核者：** 李媛

采样时间： 2026-07-31 07:35 **报告时间：** 2026-08-01 00:34

【血脂四项】

检验中心： 艾迪康

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	历史结果 2024-09-28
总胆固醇	4.87 mmol/L	<5.18 mmol/L	5.33 mmol/L ↑ 参考值：≤5.2 mmol/L	5.39 mmol/L ↑ 参考值：≤5.2 mmol/L
甘油三酯	1.12 mmol/L	<1.70 mmol/L	1.26 mmol/l	1.77 mmol/l ↑
高密度脂蛋白胆固醇	1.53 mmol/L	>1.04 mmol/L	1.50 mmol/L 参考值：0.9~2.19 mmol/L	1.47 mmol/L 参考值：0.9~2.19 mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	2.73 mmol/L	<3.37 mmol/L	2.50 mmol/L 参考值：<3.36 mmol/L	2.76 mmol/L 参考值：<3.36 mmol/L

检查者： 蓝印通 **审核者：** 李媛

采样时间： 2026-07-31 07:35 **报告时间：** 2026-08-01 00:34

【动脉粥样硬化指数】

检验中心： 艾迪康

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	历史结果 2024-09-28
动脉硬化指数（AI）	2.18 /	0.00~4.00 /	2.55 参考值：0~4	2.67 参考值：0~4

检查者： 蓝印通 **审核者：** 李媛

采样时间： 2026-07-31 07:35 **报告时间：** 2026-08-01 00:34

【甲状腺功能两项（游离）】

检验中心： 艾迪康

项目	检查结果	参考值
游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）	4.66 pmol/L	2.76~6.45 pmol/L
游离甲状腺素（FT4）	18.47 pmol/L	11.20~23.81 pmol/L

检查者： 王薇水水 **审核者：** 袁鑫源

采样时间： 2026-07-31 07:59 **报告时间：** 2026-07-31 23:18

【甲状腺功能三项（A）】

检验中心： 艾迪康

项目	检查结果	参考值
促甲状腺激素(TSH)	2.018 mIU/L	0.350~5.100 mIU/L
三碘甲状腺原氨酸（T3）	1.40 nmol/L	0.89~2.49 nmol/L
甲状腺素（T4）	94.30 nmol/L	64.36~186.64 nmol/L

检查者： 王薇水水 **审核者：** 袁鑫源

采样时间： 2026-07-31 07:35 **报告时间：** 2026-07-31 23:18

【甲状腺过氧化物抗体（TPO-AB）】

检验中心： 艾迪康

项目	检查结果	参考值
甲状腺过氧化物酶抗体	<0.25 IU/mL	≤9.00 IU/mL

检查者： 王薇水水 **审核者：** 袁鑫源

采样时间： 2026-07-31 07:59 **报告时间：** 2026-07-31 23:18

【抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）】

检验中心： 艾迪康

项目	检查结果	参考值
抗甲状腺球蛋白抗体（TG-Ab）	<0.90 IU/mL	≤4.00 IU/mL

检查者： 王薇水水 **审核者：** 袁鑫源

采样时间： 2026-07-31 07:59 **报告时间：** 2026-07-31 23:18

【多肿瘤标志物联合检测(TM5)（男）】

检验中心： 艾迪康

项目	本次结果 2026-07-31	参考值	历史结果 2025-07-30	历史结果 2024-09-28
甲胎蛋白(AFP)(发光法-定量)	2.95 ng/mL	<7.00 ng/mL	3.78 ng/ml 参考值：<10 ng/ml	4.28 ng/ml 参考值：<10 ng/ml
癌胚抗原(CEA)(发光法-定量)	1.33 ng/mL	≤5.00 ng/mL	1.36 ng/ml 参考值：0~5 ng/ml	1.66 ng/ml 参考值：0~5 ng/ml
糖类抗原19-9测定(CA19-9)	5.77 U/mL	≤34.20 U/mL	6.66 U/ml 参考值：0~35 U/ml	7.09 U/ml 参考值：0~35 U/ml
前列腺特异性抗原	0.496 ng/mL	≤4.000 ng/mL	0.520 ng/ml 参考值：<4 ng/ml	0.570 ng/ml 参考值：0.01~4 ng/ml
游离前列腺特异性抗原	0.213 ng/mL	≤1.040 ng/mL	0.284 ng/ml 参考值：≤1 ng/ml	0.251 ng/ml 参考值：0.01~1 ng/ml
f-PSA/T-PSA	0.43 /	/ /	0.55 参考值：0.25~1	0.44 参考值：0.25~0.999

检查者： 王薇水水 **审核者：** 袁鑫源

采样时间： 2026-07-31 07:35 **报告时间：** 2026-07-31 23:18

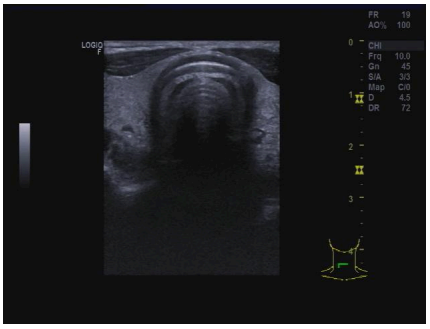
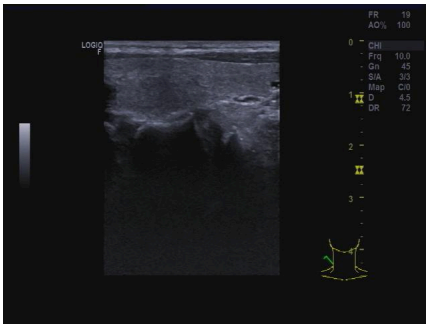
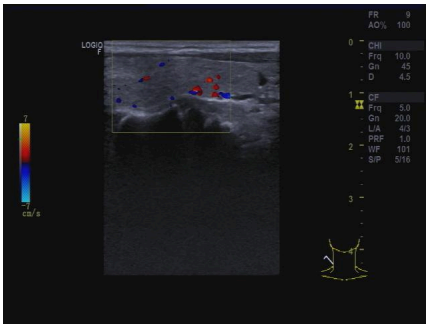
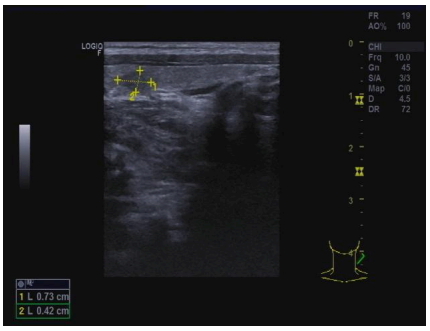
莫增涛 男 38岁

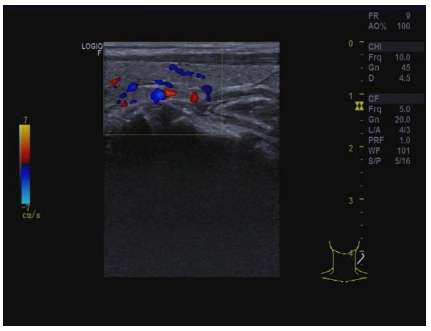
0491212607313023

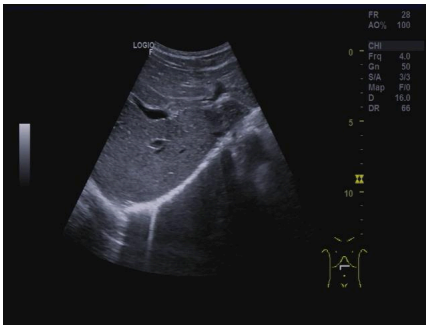
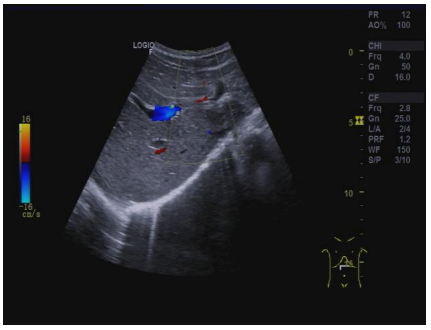
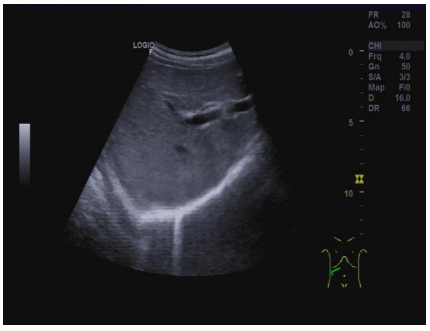
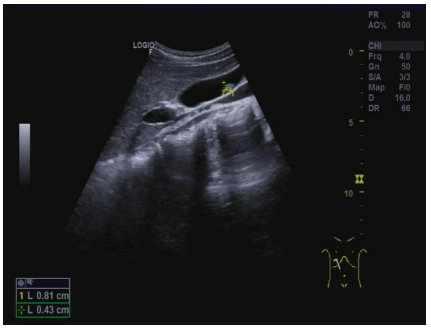
超声检查报告单 Ultrasound Examination Report

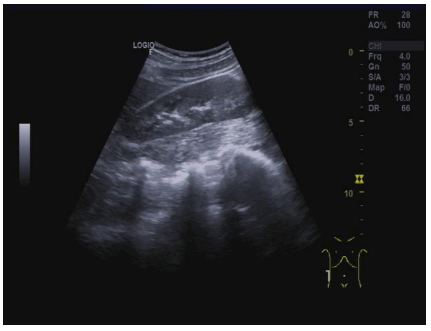
序号：1004 **检查时间：**2026-07-31 11:13 **检查科室：**彩超室

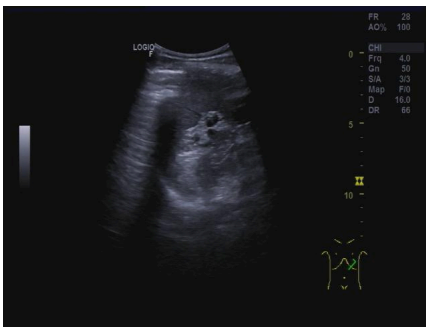
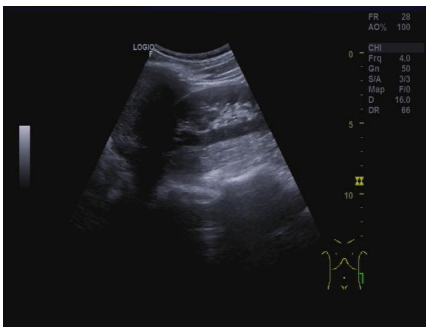
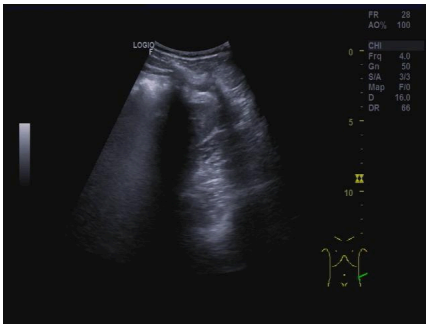
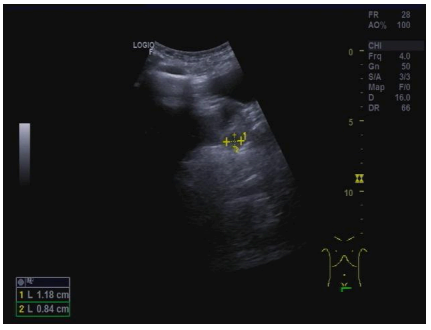
检查项目： 肝、胆、胰、脾、双肾、甲状腺、前列腺 超声检查





超声描述：

超声条件及图像质量【乙】
双叶甲状腺形态大小正常，峡部厚度正常，包膜完整，内部回声均匀。于左叶可见多个低回声光团，大者约7.3*4.2mm，边界清。CDFI：未见明显异常血流信号。
肝脏形态大小正常，实质回声分布均匀，血管纹理清晰。CDFI：未见明显异常血流信号。
胆囊大小正常范围，胆汁透声尚可，附壁探及稍高回声区，大小约8.1*4.3mm，紧贴胆囊壁，后方无声影，不随体位改变而移动。胆总管近端未见扩张。
胰腺形态大小正常，内部回声均匀，主胰管未见扩张。CDFI：未见明显异常血流信号。
脾脏形态大小正常，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：未见明显异常血流信号。
双肾形态大小正常范围，包膜光滑，集合系统未见明显分离。CDFI：血流灌注良好。
前列腺大小正常，包膜完整，内部回声均匀，内见钙化斑。其内探及无回声区，大小约11.8*8.4mm。形态呈泪滴状。

超声提示：

1.左叶甲状腺结节多发C-TIRADS 3类
2.胆囊息肉
3.前列腺囊肿
4.前列腺钙化
5.肝、胰、脾、肾目前未见明显占位性病变

注:本报告仅作临床医师参考

报告医师：

历史检查结果（2）

2025-07-30 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查项目：

肝、胆、胰、脾、双肾、甲状腺、前列腺 超声检查

超声提示：

1.左叶甲状腺结节C-TIRADS 4A类
2.甲状腺回声欠均匀
3.胆囊息肉
4.前列腺增大并钙化
5.肝、胰、脾、肾目前未见明显占位性病变

2024-09-28 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查项目：

肝、胆、胰、脾、双肾、甲状腺、前列腺 超声检查

超声提示：

1.胆囊息肉
2.前列腺钙化
3.双叶甲状腺未见明显异常
4.肝、胰、脾、肾目前未见明显占位性病变

莫增涛 男 38岁

0491212607313023

影像诊断报告单 Diagnostic Imaging Report

【CT室】

序号： 10303 **检查时间：** 2026-07-31 07:46 **检查科室：** CT室

检查项目： 肺部CT

影像描述：

胸廓对称，两肺见多发微小结节，最大者位于右肺下叶（薄层IMG78），直径约2mm，边界清晰。左肺下叶（薄层IMG168）见磨玻璃小结节，直径约5mm，边界清晰。右肺上叶见斑点、斑片及条索状高密度影，伴钙化，余两肺未见明显实变，气管及诸叶、段支气管通畅。气管旁见含气囊腔影，纵隔窗示纵隔居中，纵隔内未见明显肿大淋巴结，两侧胸腔未见明显积液征象。心脏形态、大小未见明显异常。右侧胸膜增厚伴钙化。附见肝内类圆形低密度影。

诊断提示：

右肺上叶陈旧性病灶可能，建议复查。
左肺下叶磨玻璃小结节，建议专科诊治并6个月内CT复查。
两肺多发微小结节，建议复查。
气管憩室。
右侧胸膜增厚伴钙化。
附见：肝内低密度影，请结合临床及相关检查。

注:本报告仅作临床医师参考

报告医师： 李[illegible]

报告时间： 2026-08-01

审核医师： 杨加军

审核时间： 2026-08-01 13:01

历史检查结果（2）

2025-07-30 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查项目：

肺部CT

诊断提示：

右肺上叶慢性感染性病变，建议专科随诊复查。
气管憩室。
附见：肝内低密度影，请结合临床及相关检查。

2024-09-28 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查项目：

肺部CT

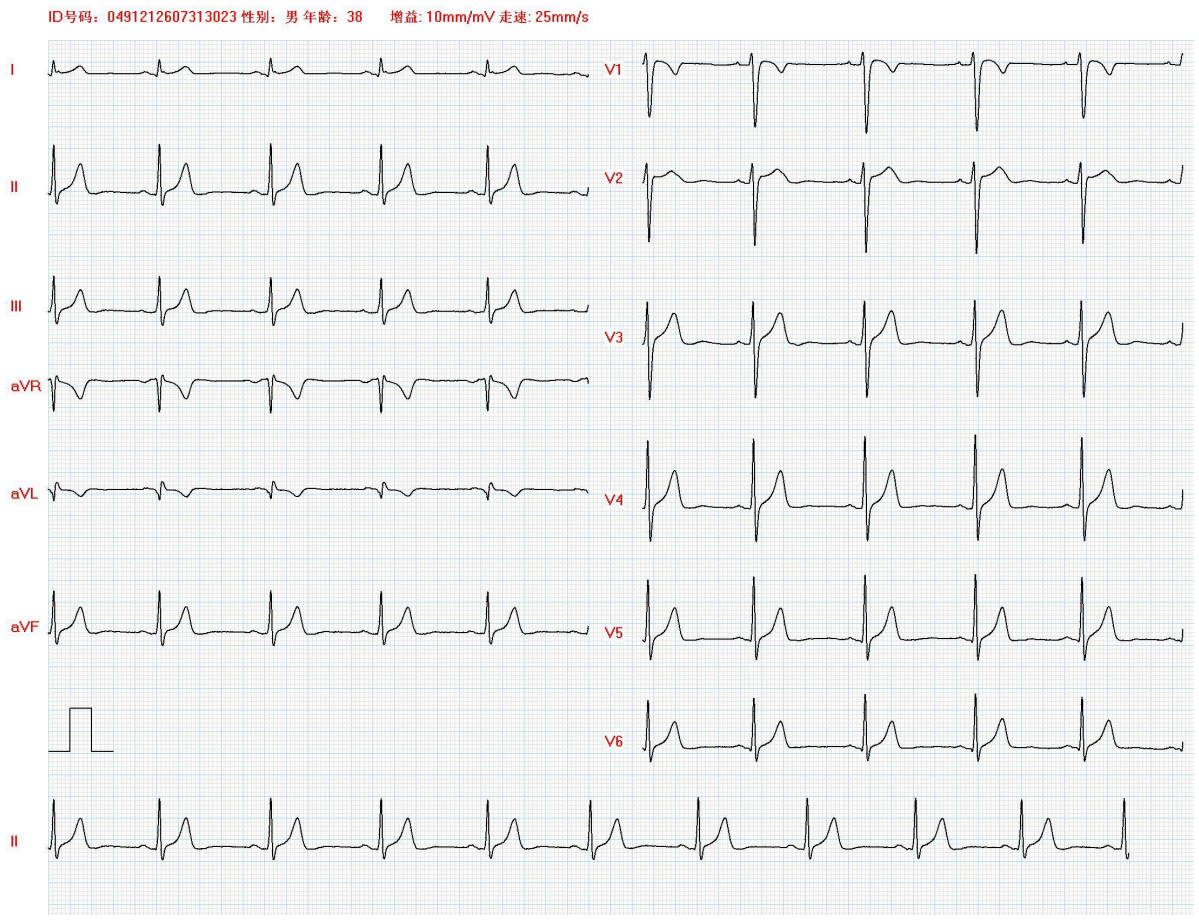
诊断提示：

右肺上叶慢性感染性病变，建议专科随诊复查。
气管憩室。

心电图检查报告单 ECG Report

序号： 1105 **检查时间：** 2026-07-31 08:10 **检查科室：** 心电图

检查项目： 静态心电图检查



心电图

检查描述：
增益: 10mm/mV 走速: 25mm/s
心率: 60 bpm
PR间期: 157 ms
QRS时限: 96 ms
QT间期: 371 ms
QTC间期: 369 ms
P电轴: -18 Angle
QRS电轴: 61 Angle
T电轴: 74 Angle
RV5: 1.49 mV
SV1: 1.55 mV

检查结果：
正常心电图

报告医师： **检查时间：** 2026-07-31 08:10 **报告时间：** 2026-07-31 09:54

历史检查结果（2）

2025-07-30 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查项目：

静态心电图检查

检查结果：

窦性心律
大致正常心电图

2024-09-28 青岛瑞慈瑞城健康管理有限公司市南门诊部

检查项目：

静态心电图检查

检查结果：

正常心电图
大致正常心电图

专家健康宣教 Expert Health Education

【前列腺钙化】

是前列腺发生炎症愈合后留下的疤痕，是前列腺结石的前兆。由于前列腺结构特殊性，发生钙化、结石一般没有较好的治疗方法。前列腺钙化（纤维化）、结石处会滋生细菌，导致前列腺炎反复发作。建议您：（1）避免劳累过度，不能熬夜，生活有规律，起居有常，防感冒；（2）忌食辛（如：海鲜）辣食物，忌烟酒；多饮水，多排尿，保持小便通畅，以帮助前列腺分泌物排出；（3）避免久坐不动；坚持适当的身体锻炼，提高自身免疫力；饮食营养丰富，增强免疫力。

【前列腺囊肿】

是先天性或后天性病变而发生囊样改变。先天性囊肿由于胚胎时期，腺体发育障碍，腺导管狭窄、梗阻，内容物滞留而形成。后天性囊肿是指出生后，前列腺因炎症、肿瘤、外伤等造成前列腺导管梗阻而形成的。前列腺囊肿本身属于良性疾病，病情发展缓慢。先天性前列腺囊肿，常常伴有尿道下裂、隐睾、生殖器发育异常，但不多见。超声及各种影像诊断，均可发现前列腺囊肿的大小、形态、数目等，诊断并不困难。建议泌尿外科随诊。

【肺部结节】

肺结节是指肺内生理或病理性组织，在CT或X线胸片上显示为局灶性、类圆形密度增高的阴影。肺内很多疾病都会形成结节，如炎症、结核、霉菌、出血、肿瘤等。多数肺结节是良性的，部分有恶性风险。肺部结节通常无症状。若首次发现肺部结节，需要医院呼吸专科医生，结合病史、症状及其他相关检查阳性结果等，对肺部结节的性质进行风险评估，并定期复查随访。吸烟者建议戒烟。如您同时伴有咳嗽、咳痰、痰中带血等不适，应及时呼吸内科就诊。

【胸膜增厚】

胸膜是一层浆膜，覆盖于肺表面及胸廓内侧面，分别称为脏层及壁层胸膜，正常胸膜在X线检查时，一般不显影。胸膜病变（胸腔积液、胸膜炎、脓胸、胸膜肿瘤）及陈旧性胸膜改变，在胸部X线、CT检查时，可表现为广泛或局限胸膜增厚、粘连及钙化等。除陈旧性胸膜改变外，胸膜增厚应定期随访；如您有咳嗽、胸闷、胸痛、发热等不适，应及时到医院呼吸内科诊治。

【胆囊息肉】

往往在体检时由超声检查时发现，其主要是胆汁中胆固醇呈过饱和状态，加之囊壁的慢性炎症，久之形成息肉样肿物。多数无临床表现，如息肉较大，少数病人可有右上腹疼痛，恶心呕吐，食欲减退；可出现右胁隐痛，或牵及右肩背，可伴有消化不良等类似慢性胆囊炎的临床表现。本病偶可发生息肉样原位癌。建议您：如果无任何不适，息肉直径小于1厘米并且短时间不增大的话，可以每6个月复查一次超声。若有出现明显的不适症状或年龄大于50岁或息肉直径超过1厘米、最好肝胆外科就诊评估手术指征。

【甲状腺结节，C-TIRADS分类】

是指甲状腺细胞在局部异常生长所引起的散在病变。在健康体检中非常多见，由多种病因引起。中国甲状腺结节超声恶性危险分层系统（C-TIRADS），为临床诊断和治疗提供较客观的依据。将甲状腺结节进行分层管理，达到合理分流，精准诊疗的效果。（解释：C-TIRADS 1-2类，恶性可能0%；C-TIRADS 3类，恶性可能＜2%；C-TIRADS 4A类，恶性可能2%～10%；C-TIRADS 4B类，恶性可能10%～50%；C-TIRADS 4C类，恶性可能50%～90%；C-TIRADS 5类，恶性可能＞90%；C-TIRADS 6类，活检证实的恶性结节）。对于体检中初次检出的甲状腺结节，无论您的甲状腺结节是什么类别，均应咨询甲状腺专科医师，经充分评估后制定个性化的随访或诊疗计划。